



DICTAMEN INDIVIDUAL DE CARÁCTER Y RIGOR CIENTÍFICO DE UNA CONTRIBUCIÓN PRESENTADA EN EL “VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD”

SUMARIO:

AUTOR

ANTECEDENTES

OBJETO DEL DICTAMEN

NORMATIVA APLICABLE

FUNDAMENTOS

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Criterios de Calidad y de Rigor

La Subjetividad, el Rigor científico, y el Rigor Metodológico

COMPOSICIÓN COMITÉ CIENTÍFICO

CONCLUSIÓN



AUTOR:

MARÍA DEL CARMEN PÉREZ FUENTES, Catedrática de Universidad. Grupo de Investigación SEJ-581: "Investigación en el Ámbito Educativo y de la Salud", de la Universidad de Almería.

ANTECEDENTES:

Los distintos procesos selectivos en las diferentes Consejerías de Sanidad y/o Salud, de las respectivas Comunidades Autónomas, constan por lo general de 3 apartados, a saber: por un lado, tenemos la experiencia profesional, por otro la formación académica y por último, un apartado de “otros méritos”, que aluden principalmente a la presentación de trabajos en reuniones, congresos, así como la publicación de trabajos mediante capítulos de libro, libros, o artículos en revistas, entre otros, tal y como se pone de manifiesto con la publicación de la última normativa en este sentido, hablamos de la Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud por la que se dispone la aprobación y publicación del texto refundido y actualizaciones del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad, suscrito entre la Administración Sanitaria de Andalucía-SAS y las Organizaciones Sindicales que se citan, el 26 de junio de 2017, sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el



Servicio Andaluz de Salud, publicada en el BOJA de fecha 05 de octubre de 2017, habiendo sido modificada por Resolución de 30 de octubre de 2018, y de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, donde consta de forma expresa en su Artículo 4. Principios generales, en su apartado número 3, *que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de gestión clínica, de prevención y de información y educación sanitarias*, e igualmente en su apartado número 6 se describe *que los profesionales sanitarios realizarán a lo largo de su vida profesional una formación continuada, y acreditarán regularmente su competencia profesional*.

Las personas que participan mediante la publicación de sus investigaciones, suelen posteriormente hacerlas valer, bien en las distintas Bolsas de trabajo que dispone cada Comunidad Autónoma, en los concursos de traslados, carrera profesional, ó bien, en lo que se conoce como la OPE, la Oferta Pública de Empleo.

Esto, no es algo nuevo, todos y cada uno de los aspirantes o integrantes en las distintas Bolsas de Empleo para desempeño en la Sanidad Pública Española, son conocedoras de la existencia de un Baremo, que consta básicamente, de esos tres apartados descritos con anterioridad.

Es por ello, que en la actualidad el marco de la investigación y así como la generación de conocimiento, necesita de forma obligatoria dotarse de unos medios que aseguren la calidad, tanto en la producción de los datos, como que los distintos métodos de investigación empleados, sean los idóneos. Es decir, la investigación necesita tener criterios de calidad y de rigor científico y/o metodológico, que garantice que las aportaciones o los trabajos, cumplan con unos mínimos y dignos aspectos para que se consideren científicas. Es por tanto, que necesitamos definir una serie de aproximaciones y llegar a un consenso en materia de rigor o calidad en la investigación, aunque no está exento de una cierta problemática impregnada por el carácter subjetivo y más si cabe en el ámbito de la Universidad, donde la enseñanza y la investigación aparecen inescindiblemente unidas a la elaboración de la ciencia, y es una exigencia de la labor científica que el investigador pueda, con toda libertad, establecer sus hipótesis, defender sus tesis y exponerlas como tales. La libertad de cátedra adquiere, por ello, su máxima dimensión y tiene, como ha señalado el Tribunal Constitucional, *"un amplio contenido positivo"*, que habilita al profesor para orientar su enseñanza de la manera que juzgue más conforme con sus convicciones (Lozano, 1997).

Llegar a un consenso en esta materia, no está exento de matices, perspectivas diversas, y sobre todo controvertidas. Es difícil, por no decir, engorroso, hay quien defiende que es imposible adaptar criterios cuantitativos al proceso de la investigación cualitativa; otros por el contrario, definen el rigor o el carácter científico como el establecimiento de medidas o parámetros que permitan transigir y avalar la credibilidad, la autenticidad, y la certidumbre de los resultados obtenidos, entre algunos factores.



OBJETO DEL DICTAMEN:

Acreditación Individual del Carácter y/o Rigor Científico de una contribución (Comunicación o Póster) presentada en el “VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD”, durante los días 11 y 12 de septiembre de 2025. Organizado por el Grupo de Investigación SEJ-581 de la Universidad de Almería, la Sociedad Científica Española para la Investigación y Formación en Ciencias de la Salud e Investigación y Formación en Psicología, Educación y Salud.

NORMATIVA APLICABLE:

- a. Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica parcialmente el texto refundido y actualizaciones del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad suscrito el 26 de junio de 2017 entre la Administración Sanitaria de Andalucía-SAS y las Organizaciones Sindicales, sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud.
- b. Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone la aprobación y publicación del texto refundido y actualizaciones del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad, suscrito entre la Administración Sanitaria de Andalucía-SAS y las Organizaciones Sindicales que se citan, el 26 de junio de 2017, sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud.
- c. Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 21 de junio de 2010, por la que se dispone la aprobación y publicación del texto refundido y actualizaciones del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad suscrito el 18 de mayo de 2010 entre la Administración Sanitaria de Andalucía-SAS y las Organizaciones Sindicales que se citan, sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud.
- d. Resolución de 12 de junio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica parcialmente el texto refundido y actualizaciones del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad suscrito el 18 de mayo de 2010 entre la Administración Sanitaria de Andalucía-SAS y las Organizaciones Sindicales -SATSE, CC.OO., UGT, CSI-CSIF, SMA y USAE-, sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud.
- e. Resolución de 25 de agosto de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica parcialmente el texto refundido y actualizaciones del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad suscrito el 18 de mayo de 2010 entre la Administración Sanitaria de Andalucía-SAS y las Organizaciones Sindicales -SATSE, CC.OO., UGT, CSI-CSIF, SMA y USAE- sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud.





- f. Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica el texto refundido y actualizaciones del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad suscrito el 18 de mayo de 2010 entre la Administración Sanitaria de Andalucía-SAS y las organizaciones sindicales –SATSE, CC.OO., UGT, CSI-CSIF, SMA y USAE–, sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud.
- g. Resolución de 21 de junio de 2010, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone la aprobación y publicación del Texto Refundido y actualizaciones del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad, suscrito entre la Administración Sanitaria de Andalucía-SAS y las Organizaciones Sindicales -SATSE, CC.OO., UGT, CSI-CSIF, SMA y USAE-, el 18 de mayo de 2010, sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud. (BOJA núm 137 de 14 de julio de 2010).
- h. Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020.
- i. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
- j. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

FUNDAMENTOS:

Dar a conocer los resultados de las investigaciones es inmanente, es consustancial, a la construcción del conocimiento, y debería de ser una obligación para cualquier profesional que preste sus servicios en Centros o Instituciones relacionadas con el ámbito de la Salud, pudiendo afirmar, que la ciencia que no se publica, no existe. Es un deber ético, por tanto, de los profesionales dar a conocer sus investigaciones, intentando que llegue al mayor público de su ámbito científico posible; y obviamente, y junto a este inexcusable deber moral, existe otra justificación para la publicación de sus investigaciones, y es el reconocimiento y la promoción académica y/o profesional en la institución donde presta sus servicios, y es digno de elogio, el esfuerzo que dichos profesionales están realizando, en divergencia con aquellos que deciden anquilosarse, acomodarse o atrofiarse desde el punto de vista de la carrera profesional o ámbito académico, y que puede comprobarse en los distintos informes de actividad investigadora que se publican.

Por tanto, las instituciones sanitarias, y en virtud del artículo 11 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, que obliga 1.- a toda la estructura asistencial del sistema sanitario para que esté en disposición de ser utilizada para la investigación sanitaria y para la docencia de los profesionales.

2. Las Administraciones sanitarias, en coordinación con las Administraciones educativas, promoverán las actividades de investigación y docencia en todos los centros Sanitarios, como elemento esencial para el progreso del sistema sanitario y de sus profesionales.

Los titulares de los centros sanitarios y los servicios de salud podrán formalizar convenios y



conciertos con centros de investigación, públicos o privados, y con otras instituciones que tengan interés en la investigación, públicos o privados, y con otras instituciones que tengan interés en la investigación sanitaria, para el desarrollo de programas de investigación, para la dotación de plazas vinculadas, o específicas de investigador, en los establecimientos sanitarios, para la designación de tutores de la investigación y para el establecimiento de sistemas específicos de formación de investigadores durante el período inmediatamente posterior a la obtención del título de especialista.

Existen, igualmente, varias razones también para publicar las investigaciones: se ha realizado un gran trabajo y lo quiere dar a conocer..., se quiere obligar así mismo con el fin de estudiar y avanzar..., se quiere abrir una línea de investigación que le permita participar en Congresos, cursos, etc..., por la satisfacción personal de contribuir al desarrollo de la ciencia..., ir construyendo un currículum..., en definitiva, sea cual sea la razón, siempre la sociedad lo verá como algo positivo.

CRITERIOS DE VALORACIÓN:



Criterios de Calidad y de Rigor

Para el análisis de cada una de las aportaciones que se han evaluado en *VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD*, se han utilizado una serie criterios de valoración, para poder ponderar la novedad científica de la publicación y/o la calidad de la misma, y que son básicamente los que rigen actualmente el conocimiento científico, teniendo presente que la presentación de trabajos en un Congreso, puede considerarse como el nivel más básico de la investigación.

El rigor llega implícito, un entramado conceptual y técnico, que se compone de varias vertientes y que entre todas, dotan a los trabajos de esa “calidad” ó “rigor” que todas las investigaciones deben de tener. El rigor está integrado, por la calidad de los datos producidos, y cómo no, por los análisis empleados para la consecución de los objetivos; pero también, como apunta Cornejo (2008), íntimamente relacionado con los reportes de investigación generados o a los diversos procedimientos de investigación utilizados, por todo lo anterior se describen aquellos criterios susceptibles de valorar el carácter o rigor científico de un trabajo, a saber:

- a. **Credibilidad del trabajo:** el rigor científico implica una valoración de la situación, en la cual dicha investigación puede ser considerada como creíble, y para este fin, lo relevante es que los datos expuestos puedan ser demostrados en los resultados del trabajo realizado, constatando que exista una estimación valorativa de los datos o información, que sea derivada del método empleado. Se refiere a la congruencia de los hallazgos con la realidad, mediante la utilización de instrumentos o medios para la consecución de tal fin, como por ejemplo: entrevistas, análisis de datos, el análisis conjunto de diversos aspectos o características técnicas, mediante grupos focales, revisiones sistemáticas, reflexiones o revisiones teóricas, etc.



- b. **Transferencia:** es fundamental, es uno de los ejes que de no existir, no habría investigación, y conocimiento científico. La transferencia del conocimiento y la colaboración investigadora y formativa de los centros de trabajo (hospitales, centros de salud, etc.), así como, el emprendimiento por parte de los profesionales de la Salud, tiene un claro objetivo, que es promover y promocionar la capacidad innovadora de los grupos de investigación o de sus Centros para dar a conocer sus trabajos. Se requiere especificar el número de participantes en el trabajo en cuestión, así como todos aquellos elementos necesarios.
- c. **Dependencia:** entendida como el grado de estabilidad o nivel de consistencia de los resultados obtenidos en el estudio. Por ello, puede manifestarse que existe una coherencia entre las temáticas que son susceptibles y objeto en un congreso de Salud. Para ello se debe de incluir en la investigación los datos referentes al diseño del estudio para comprender el método utilizado y su efectividad.
- d. **Confirmación y coherencia de la investigación desarrollada:** los autores de los trabajos, deben de tener una implicación, tal que se extienda la garantía suficiente sobre el proceso de la investigación, ya sea cuantitativa o investigación teórica, fruto de sus reflexiones y revisión de la literatura referente al tema en cuestión, debiendo utilizar para ello un análisis e integración de la información.
Del mismo modo Calderón (2002) apunta cuatro criterios más, en relación a la investigación en Salud, que podemos resumirlos en:
- e. **Adecuación epistemológica:** un criterio sustancial en las investigaciones cualitativas son las distintas fases del aspecto que se quiere investigar, tienen que estar perfectamente definidas, han de mostrar coherencia, tanto con el tipo de pregunta que se formula, hasta con la relación con la premisa teórica de la cual se parte.
- f. **Relevancia:** encadenada principalmente con la justificación y las consecuencias que se derivarán de la investigación, al objeto de tener un mayor conocimiento del asunto que se ha investigado, por lo tanto, ha de estar perfectamente descrita la finalidad de la investigación, y más si cabe, en el ámbito de la Salud.
- g. **Validez:** es un criterio, quizás el más representativo, en el contexto de la investigación, atendiendo a las diferentes vertientes que ello conlleva, la validez externa, la representatividad, y sobre todo la generalización de los resultados.
- h. **Reflexividad:** una investigación cualitativa requiere de ciertas dosis de interpretación, tal y como afrontaremos más adelante, pero nadie mejor que un profesional de la Salud, con su formación de procedencia, para poder aproximarse desde su óptica, para enfrentarse al estudio y su influencia que puede ejercer en el resultado de la investigación.
- i. **Auditabilidad:** Guba y Lincoln (1981) se refieren a este concepto en el sentido, de que otra persona pueda seguir el “rastreo” o la “pista” del origen de la investigación.





La Subjetividad, y el Rigor científico

A la hora de plantear una investigación, el carácter subjetivo de la misma es inherente al proceso, en el sentido de la influencia del investigador, su curiosidad, y su responsabilidad en el procedimiento, debiendo en todo caso, el investigador, de describir o hacer explícita dicha subjetividad, aunque la realidad o el ámbito en el que se produce la investigación, sea un contexto objetivo. Por tanto, y según detalla Cornejo et al. (2011), y Cisterna (2005) se deben de establecer, en las etapas centrales del proceso investigativo, instancias para que los investigadores reflexionen entorno a su propia subjetividad. Por otra parte, en el proceso de transparencia con los datos, se debiera de explicitar cómo se planteó dicha investigación, de dónde nació, así como el lugar que éste posee dentro del marco interpretativo de los datos producidos, igualmente, debiera de reconocer cuáles premisas, supuestos, y ejes temáticos personales del investigador están en juego a la hora del tratamiento de la información, todo ello permitiría mejorar la rigurosidad y la calidad de lo que se presenta en una investigación.



Rigor Metodológico

Cualquier resultado de investigación tiene que tener o haber implementado un riguroso procedimiento a nivel metodológico, donde la reflexión o la revisión, en el caso de las investigaciones cualitativas; o por el contrario, la contrastación en el caso de los trabajos empíricos, deben ser los ejes transversales por lo que discurre todo el proceso de investigación. Por lo tanto, el método por el cual se ha llegado a los resultados tiene que estar perfectamente definido, independientemente del tipo de investigación desarrollada, y siempre teniendo presente, tal y como antes se ha señalado, el carácter epistemológico y el procedimiento para la obtención de los datos.

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO:

PRESIDENTA Dra. D ^a . M ^a del Mar Molero Jurado Profesora Titular de Universidad Universidad de Almería	
Dra. D ^a . Bárbara Badanta Romero Profesora Titular de Universidad Universidad de Sevilla	Dra. D ^a . Ana Belén Barragán Martín Profesora Permanente Laboral Universidad de Almería
Dr. D. Javier Benítez Rivero Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz	Dr. D. Alejandro Caña Pino Profesor Ayudante Doctor Universidad de Extremadura
Dr. D. Manuel Coheña Jiménez Profesor Titular de Universidad Universidad de Sevilla	Dr. D. José Manuel Delfa de la Morena Profesor Contratado Doctor Universidad Rey Juan Carlos



Dr. D. Diego Ramón Dueñas Alcalá Médico Psiquiatra Hospital Universitario Torrecárdenas	Dra. Carmen Frontela Saseta Profesora Titular de Universidad Universidad de Murcia
D ^a . Claudia García Abad Doctoranda Universidad de León	Dr. D. José Jesús Gázquez Linares Catedrático de Universidad Universidad de Almería
Dra. D ^a . Kelly Myriam Jiménez de Aliaga Directora de Innovación y Transferencia Tecnológica Universidad Nacional Autónoma de Chota	Dra. D ^a . Isabel López-Chicheri Profesora de Universidad Universidad Católica San Antonio de Murcia
Dra. D ^a . Paloma López Ros Profesora Permanente Laboral Universidad Miguel Hernández de Elche	Dra. D ^a . María del Pilar Madrigal Verdú Profesora Ayudante Doctora Universidad Miguel Hernández de Elche
Dra. D ^a . Vicenta Martínez Córcoles Profesora de Universidad Universidad Católica San Antonio de Murcia	Dra. D ^a . África Martos Martínez Profesora Permanente Laboral Universidad de Almería
Dra. D ^a . Inmaculada Méndez Mateo Profesora Titular de Universidad Universidad de Murcia	Dr. Jennifer Morozink Boylan Associate Professor University of Colorado Denver
Dr. D. Vicente Navarro López Profesor de Universidad Universidad Católica San Antonio de Murcia	Dra. D ^a . María Victoria Palop Montoro Profesora de Universidad Universidad Católica San Antonio de Murcia
Dra. D ^a . María del Carmen Pérez-Fuentes Catedrática de Universidad Universidad de Almería	Dr. D. Raúl Quevedo Blasco Profesor Titular de Universidad Universidad de Granada
Dr. D. José Manuel Rodríguez Ferrer Catedrático de Universidad Universidad de Granada	Dr. D. Antonio José Sánchez Guarnido Psicólogo Clínico Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Dra. D ^a . María del Mar Simón Márquez Profesora Ayudante Doctora Universidad de Almería	Dra. D ^a . Elizabeth Valdivieso Blanco Profesora Colaboradora Doctora Universidad San Pablo-CEU





Es por ello, que quien suscribe este dictamen, emite la siguiente

CONCLUSIÓN:

Que la presente aportación de Póster que lleva por título: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON DEPRESIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA, realizada por MARINA HERNÁNDEZ CASTILLO, RAQUEL MARIA LÁZARO AZNAR y NOELIA ARCOS FERNANDEZ, cumple con los siguientes **Criterios de Calidad y Valor Intrínseco, que constatan el CARÁCTER Y RIGOR CIENTÍFICO de una aportación presentada en un Congreso, en base a una serie de aspectos característicos de la investigación, así como de los CRITERIOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, SIN PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN RELACIÓN A LA CATEGORÍA PROFESIONAL:**



1. **Originalidad:** El trabajo ha sido comprobado por personal especializado, además se ha examinado con el programa ANTI-plagio “iThenticate plagiarism”. Es, igualmente, un trabajo original en su campo de intervención, sin mensurar de forma concreta el alcance de dicha publicación, y su contribución al progreso de la ciencia.
2. **Publicación:** El abstract de la aportación ha sido publicado en las Actas del VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD, Volumen I , que posee su correspondiente ISBN: 979-13-87910-04-4 además de su Depósito Legal: AL 6171-2025. Esta publicación tiene una difusión INTERNACIONAL con un número de ejemplares elevado.
3. **Temática de salud:** La citada aportación se encuadra dentro del ámbito o temática de *Enfermería Comunitaria*.
4. **Aportación científica al ámbito sanitario:** Supone un acercamiento teórico/empírico con el objetivo de identificar las principales estrategias, buenas prácticas y dificultades en el abordaje de la depresión en atención primaria por parte de enfermería. Esta reflexión, revisión teórica o de investigación en la valoración de la atención de enfermería en pacientes con depresión en atención primaria, contempla los diferentes apartados que todo estudio de investigación debe reflejar: Introducción, Objetivo, Método, Resultados y Conclusión/Discusión.



5. Para **ACCEDER al texto original** de la Comunicación/Póster y comprobar la AUTENTICIDAD y VALIDEZ de este documento puede acceder a este enlace: https://ciiias.es/6/contenido/validar_certificado e introducir el siguiente código de validación: **4365OC**

Almería, a 12 de septiembre de 2025



Fdo: María del Carmen Pérez Fuentes
Catedrática de Universidad